

פרק 27

יתר לחץ דם בנשים

ד"ר אורית קלוק בן בסט

ד"ר נגה פורת

יתר לחץ דם הינו גורם סיכון חשוב לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית בנשים, המושפע מגורמים הורמונליים, ביולוגיים וחברתיים. ישנם הבדלים מגדריים בולטים ביותר לחץ דם: אטיולוגיות שניוניות שהינן אופייניות יותר בנשים לעומת גברים (כדוגמת Fibromuscular dysplasia), הבדלים בהשלכות פתופיזיולוגיות של יתר לחץ דם כגון היפרטרופיה של החדר השמאלי והפרעה דיאסטולית הנפוצות יותר בנשים, הבדלים בהשפעות התרופות ופרופיל תופעות לוואי שונה ועוד (1).

לאורך חיי האישה - מההתבגרות ועד הגיל המבוגר - קיימים שלבים ייחודיים בהם הסיכון ליתר לחץ דם עולה. בגיל ההתבגרות ישנה עלייה בשכיחות גורמי סיכון ליתר לחץ דם כגון השמנה וחוסר פעילות גופנית. בתקופת הפוריות שימוש בגלולות למניעת היריון עשוי להביא לעליית לחץ דם, מצבי יתר לחץ דם בהיריון, כולל רעלת היריון ויתר לחץ דם הריוני, מעלים את הסיכון ליתר לחץ דם ומחלות קרדיווסקולריות בהמשך החיים. בעוד שכיחות יתר לחץ דם בנשים בגיל הפוריות נמוכה משמעותית לעומת גברים, סביב המנופאזה יש עלייה באבחון המחלה בצורה חדה ומעל גיל 60-65 שכיחותה גבוהה מאשר בגברים (1).

בפרק זה נתמקד בשימוש בטיפול למניעת היריון ויתר לחץ דם במנופאזה. יתר לחץ דם בהריון יידון בפרק 26.

אמצעים הורמונליים למניעת היריון

תרופות הורמונליות ניתנות בעיקר באינדיקציה של מניעת היריון אך גם לטיפול במצבים רפואיים שונים כגון הסדרת הווסת, דיסמנוריאה, טיפול באנדומטריוזיס, תסמיני שחלות פוליציסטיות ועוד. קיימות מספר צורות מתן: פומית, עורית, הזרקה לשריר או וגינלית.

ככלל, אמצעים למניעת היריון המכילים אסטרוגן או המשלבים אסטרוגן ופרוגסטרון הם סיבה שכיחה יחסית ליתר לחץ דם תרופתי בנשים צעירות, ומומלץ להימנע משימוש בהם בנשים עם יתר לחץ דם מאובחן אלא בהעדר חלופה מתאימה. המרכיב האסטרוגני בגלולות הוא הגורם העיקרי לעלייה בלחץ הדם, כאשר המנגנון המרכזי הינו עלייה ביצור angiotensinogen בכבד הגורמת לשפעול ציר הרנין-אנגיוטנסין. תחילה נראה עלייה בפעילות הרנין (PRA) ועלייה באנגיוטנסין I, ובהמשך מנגנון של היזון חוזר יביא לירידה בריכוז הרנין (DRC) (2). התכשירים הקיימים כיום מכילים מינונים נמוכים יותר של אסטרוגן מבעבר, אך הסיכון לעלייה בלחץ הדם קיים, בעיקר בשימוש ממושך. על כן חשוב לבצע הערכת גורמי סיכון טרם התחלת טיפול (2).

בנוסף לגלולות המשלבות אסטרוגן ופרוגסטרון, ישנן גלולות המכילות פרוגסטרון בלבד, הנקראות גם mini-pill, ואלה נחשבות בטוחות גם בנשים עם יתר לחץ דם (3).

לאור זאת, ההמלצות לטיפול למניעת היריון בנשים עם יתר לחץ דם הינן:

בנשים עם יתר לחץ דם מאוזן, אין סיכון מוגבר בשימוש בהתקנים תוך רחמיים, מצופי נחושת או הורמונליים, וכן בגלולות המכילות פרוגסטרין בלבד.

שימוש בזריקת דפו-פרובר DMPA = depot medroxyprogesterone acetate בנשים אלו עשוי להיות כרוך בסיכון קל לעליית לחץ דם אך אין מניעה משימוש.

לעומת זאת, גלולות המשלבות אסטרוגן ופרוגסטרון עשויות להביא בסבירות גבוהה ליציאה מאיזון לחץ הדם ולכן אינן

מומלצות. במידה וניתנות הגלולות המשולבות, יש לבחור בתכשיר המכיל מינון נמוך ככל האפשר של אסטרוגן (4).
בנשים עם יתר לחץ דם לא מאוזן, אמצעי המניעה המועדף הינו התקן תוך רחמי מצופה נחושת.
 ניתן להשתמש גם בהתקן הורמונלי ובגלולות המכילות פרוגסטרין בדרגת סיכון מעט גבוהה יותר.
 הסיכון בשימוש ב-DMPA, ויותר מזה בגלולות המשולבות אסטרוגן ופרוגסטרון, הינו גבוה ועל כן יש להימנע ככל הניתן משימוש בתרופות אלו (5).

להלן ההמלצות לשימוש בגלולות למניעת הריון בהתאם למידת איזון לחצי הדם ומחלות הרקע הנוספות (2):

גלולות משולבות אסטרוגן + פרוגסטרון	גלולות המכילות פרוגסטרון בלבד	
יתר לחץ דם מאוזן	הסיכון לרוב עולה על התועלת, שימוש רק אם אין חלופה מתאימה	אין מגבלה בשימוש
סיסטולי 140-159 מ"מ"כ / דיאסטולי 90-99 מ"מ"כ	הסיכון לרוב עולה על התועלת, שימוש רק אם אין חלופה מתאימה	אין מגבלה בשימוש
סיסטולי < 160 מ"מ"כ / דיאסטולי < 100 מ"מ"כ	יש להימנע	יתרונות השימוש עולים על החסרונות
יתר לחץ דם מלווה במחלה וסקולרית	יש להימנע	יתרונות השימוש עולים על החסרונות
ריבוי גורמי סיכון למחלה אtherosclerotic	הסיכון לרוב עולה על התועלת, מומלץ להימנע	יתרונות השימוש עולים על החסרונות
לחץ דם תקין בנוכחות היסטוריה של לחץ דם גבוה במהלך הריון	יתרונות השימוש עולים על החסרונות	אין מגבלה בשימוש

לפני התחלת טיפול בגלולה משולבת למניעת הריון יש למדוד לחץ דם, ולאחר מכן לבצע מדידה במהלך ביקורי המעקב, ולפחות פעם בשנה (2).

יש לשים לב כי החומרים הפעילים בגלולות עשויים להשפיע לא רק על לחץ הדם אלא גם על מאזן אלקטרוליטרי ועל תבחינים לבירור גורמים שניוניים ליתר לחץ דם. דרוספירנון drospirenone הינו פרוגסטרון סינטטי הניתן בשילוב עם רכיב אסטרוגני. חומר זה הינו בעל השפעה אנטי מינרלוקורטיקואידית, בדומה לספירונולקטון. לכן בנשים בסיכון לפתח היפרקלמיה, בין אם בשל מצב רפואי או בשל תרופות, יש להיזהר בשימוש בתרופה זו. כמו כן, דרוספירנון מעלה רמות אלדוסטרון ורנין ועלולה לגרום לתוצאה חיובית כוזבת בבירור היפראלדוסטרניזם ראשוני (6).

נטילת גלולות המכילות דרוספירנון מעלה רנין (תשובה שלילית כוזבה) ומעלה אלדוסטרון (תשובה חיובית כוזבה) ועל כן מקשה על ניתוח תוצאות רנין, אלדוסטרון (בדומה ללקיחת הבדיקה תחת מעכבי MR אחרים כדוגמת אלדקטון/ספירונולקטון).

יתר לחץ דם במנופאזה

בגיל המעבר חלה ירידה ברמות אסטרדיול וביחס אסטרוגן/טסטוסטרון, הקשורה לפגיעה בתפקוד האנדותרל. זאת במקביל לעלייה במשקל ובשכיחות סוכרת סוג 2, הגברת פעילות סימפטטית, עלייה בהפרשת רנין וברמות אנגיוטנסין II, המפחית זמינות Nitric Oxide ומעלה את רמות האנדותרלין. שניהם יחד תורמים לרגישות למלח ולהעלאת הטון הווסקולרי הכליתי, טרשת עורקים ועלייה בלחץ הדם (1).

טיפול הורמונלי באסטרוגן יעיל לתסמינים הוזהמוטורים ותסמינים נוספים של מנופאזה, כמו גם במניעת אוסטאופורוזיס.

אמנם בעבר עלה חשש כי הטיפול ההורמונלי מעלה סיכון קרדיווסקולרי, מחקרים הדגימו כי הסיכון הקרדיווסקולרי תלוי בתזמון התחלת הטיפול ההורמונלי. אסטרוגן נחשב בטוח כאשר ניתן בנשים מתחת גיל 60 או בטווח של 10 שנים מהופעת המנופאזה, בעוד בשלבים מאוחרים יותר ובנוכחות אתרוסקלרוזיס מוכח הוא כרוך בתוצאים קרדיווסקולריים שליליים (7).

אמנם מחקרים בנשים עם יתר לחץ דם לא הראו שינוי באיזון לחץ הדם עם טיפול הורמונלי חליפי, במחקר ה-Women's Health Initiative (WHI) שהינו מחקר ה-RCT הגדול ביותר שבחן השפעת טיפול הורמונלי בנשים במנופאזה, נמצא שהטיפול באסטרוגן העלה את לחצי הדם הסיסטוליים ב-1.5-1 מ"מ בממוצע, ולכן עשוי לגרום לעלייה בסיכון הקרדיווסקולרי בנשים אלו (8). לאור זאת, נשים עם יתר לחץ דם כרוני נחשבות כקבוצה בעלת סיכון בינוני לטיפול הורמונלי חליפי ואנו ממליצים לנהוג בזהירות תוך מעקב בעת מתן טיפול בנשים אלו.

בבחירת התכשיר לטיפול בתסמיני גיל המעבר בנשים עם יתר לחץ דם, מומלץ מתן אסטרוגן טרנס דרמלי (בגל או מדבקה) על מנת למנוע את ה-first path בכבד. המרכיב הפרוגסטרונגי - יש להעדיף Micronized progesterone, Dydrogesterone, Drospirenone (9).

מומלץ מעקב ל"ד לאחר 3 חודשים מתחילת הטיפול ואחת לשנה.

לחץ דם לא מאוזן, מעל 180/110, הינו התווית נגד לטיפול בשל חשש מעלייה בסיכון לאירוע מוחי, ועל כן יש לאזן את לחץ הדם טרם התחלת טיפול (7).

References:

1. Wenger, N.K., et al., Hypertension Across a Woman's Life Cycle. J Am Coll Cardiol, 2018. 71(16): p. 1797-1813.
2. Cameron, N.A., C.A. Blyler, and N.A. Bello, Oral Contraceptive Pills and Hypertension: A Review of Current Evidence and Recommendations. Hypertension, 2023. 80(5): p. 924-935.
3. Glisic, M., et al., Association between progestin-only contraceptive use and cardiometabolic outcomes: A systematic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol, 2018. 25(10): p. 1042-1052.
4. Jones, D.W., et al., 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Hypertension, 2025. 82(10): p. e212-e316.
5. Nguyen, A.T., et al., U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024. MMWR Recomm Rep, 2024. 73(4): p. 1-126.
6. McEvoy, J.W., et al., 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J, 2024. 45(38): p. 3912-4018.
7. Cho, L., et al., Rethinking Menopausal Hormone Therapy: For Whom, What, When, and How Long? Circulation, 2023. 147(7): p. 597-610.
8. Shimbo, D., et al., The effect of hormone therapy on mean blood pressure and visit-to-visit blood pressure variability in postmenopausal women: results from the Women's Health Initiative randomized controlled trials. J Hypertens, 2014. 32(10): p. 2071-81; discussion 2081.
9. Menopausal hormone therapy in women with medical conditions Kapoor E, Kling JM, Lobo AS, Faubion SS. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2021 Dec;35(6)